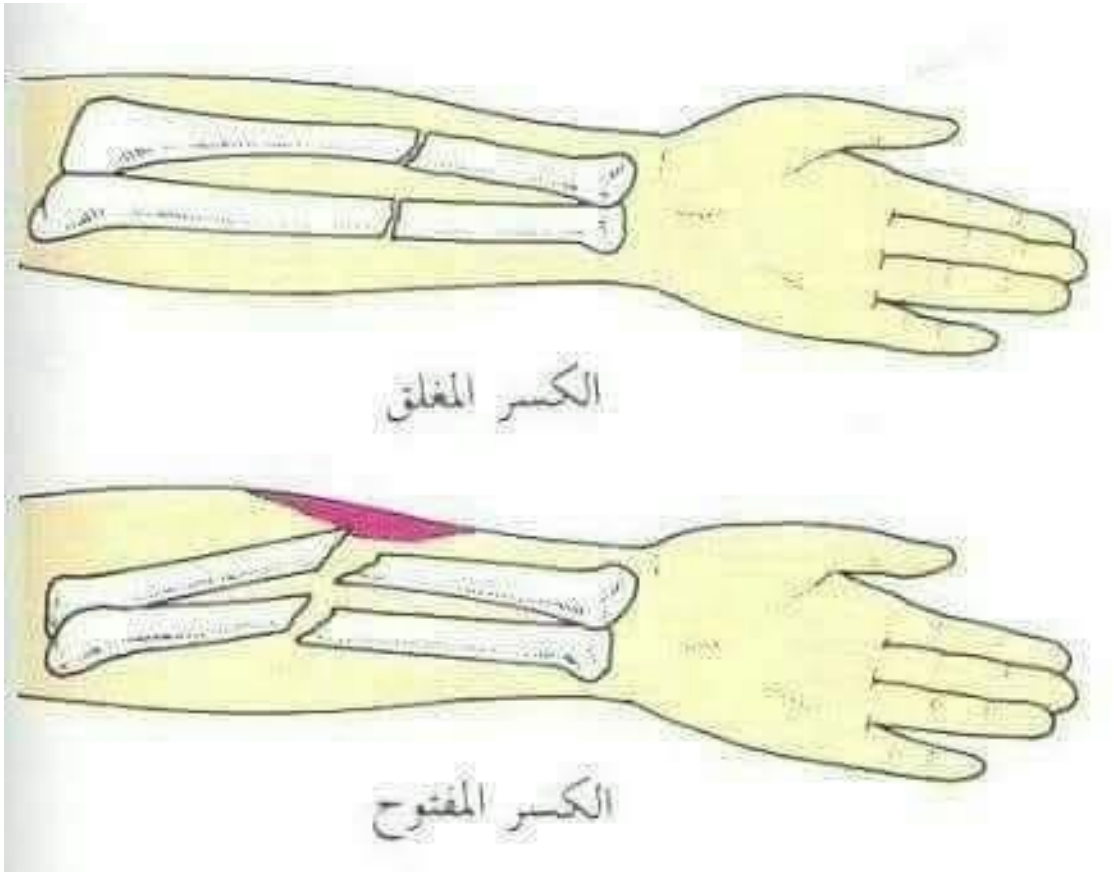
إسعاف الكسور

الكسور المضاعفة المفتوحة:

ويكون فيها الكسر بارز إلى الخارج مصحوب بالنزف.



الكسور البسيطة أو المغلقة:

يكون فيها الكسر مغلق مع وجود ورم في مكان الإصابة مع وجود آلام شديدة.

ما هو التجبير؟

التجبير هو وضع دعامة ساندة لذراع أو ساق المصاب الذي يخشى أن تكون ذراعه أو ساقه قد تعرضت للكسر.

والهدف من التجبير هو:

وقف الألم في الطرف المصاب.

سند النهايات العظمية لمنطقة الكسر. تكون النهايات العظمية في منطقة الكسر حادة جدا، وتحول عملية التجبير دون اختراق هذه النهايات العظمية الحادة للجلد و دون تمزق العضلات والأنسجة المحيطة بها كما أن التجبير يقلل من النزف في الطرف المصاب.

تسهيل عملية نقل المصاب بأمان وراحة.

ما هي الجبيرة؟

في الحالات الطارئة يمكن استخدام إي شيء كجبيرة، وهناك نوعان من الجبائر: (جبيرة صلبه - جبيرة مرنه)

الجبيرة الصلبه: أي جسم صلب، كأن يكون قطعة من الخشب أو البلاستيك، عصا مكنسه، كتاب، رزمة جرائد، ويمكن استخدام هذه المواد كجبائر للذراع أو الساق المكسوره.
الجبيرة المرنه: أي جسم مرن القوام، كأن يكون وسادة.أو غطاء سرير مطوي عدة طيات. وتصلح هذه المواد كجبائر لكسور القدم والكاحل والمفاصل.

ما هو الوشاح الطبي والرباط؟

الوشاح الطبي عبارة عن قطعة من القماش تستخدم لتثبيت ذراع مكسورة إلى جسم المصاب، ويكون التثبيت عادة في وضع الكوع المثني. ويكون الوشاح في العادة على شكل مثلث كبير الحجم، ويمكن استخدام هذا الوشاح بالإضافة الى جبيرة صلبة كما يمكن استخدامها بدلا عن الجبيرة. إذا استخدم الوشاح منفردا بدون جبيرة فيجب تعزيزه بقطعة إضافية تسمى الرباط، والرباط نفسه عبارة عن وشاح تعليق يتم طيه بحيث يكون عرضه ٥ أو ٦ بوصات.

المبادىء العامة للتجبير:

هناك الكثير من الأساليب المتبعة في التجبير وقد تبدو هذه الأساليب للوهلة الأولى بالغة التعقيد إلا أنها في واقع الأمر سهلة للغاية.

فيما يلي عرض للمبادىء العامة التي يجب مراعاتها عند القيام بتجبير الإطراف:

١-اكشف عن منطقة الإصابة

٢-أوقف النزف باستخدام الضمادات، ولكن حاذر أن تضغط على الجزء المؤلم الذي تعرض للإصابة وظهرت عليه علامات التشوه

٣-في حالات كسور العظام التي تكون النهايات العظمية فيها قد اخترقت الجلد وبرزت للخارج يجب عدم دفع هذه النهايات إلى مكانها لأن ذلك يسبب الالتهاب كما يسبب نزفا حادا.

٤-يجب إبقاء العظم المكسور (بما في ذلك المفصل الواقع فوق منطقة الكسر والمفصل الواقع تحت منطقة الكسر) ساكنا دون حركة وذلك على النحو التالي:

إذا كان الكسر في الجزء السفلي من الذراع فيجب إبقاء كل من مفصل الكوع ومفصل الرسغ ساكنين.

إذا كان الكسر في الجزء العلوي من الذراع فيجب إبقاء كل من مفصل الكوع ومفصل الكتف ساكنين.

إذا كان الكسر في الجزء السفلي من الساق فيجب إبقاء كل من مفصل الركبة ومفصل الكاحل ساكنين.

إذا كان الكسر في الجزء العلوي من الساق فيجب إبقاء كل من مفصل الركبة ومفصل الورك ساكنين.

٥-يجب ربط الجبيرة بشكل محكم لمنع حركة الطرف المكسور مع مراعاة عدم شد الجبيرة على الطرف أكثر من اللازم حيث أن ذلك يؤدي إلى حبس الدورة الدموية عن الطرف المكسور يعمل التجبير الصحيح على تخفيف الألم الذي يعاني منه المصاب.

٦-إذا كان الطرف المكسور منثيا وكانت النهايات العظمية فيه بارزة فلا تحاول تحريكها. قم بتجبير الطرف في الوضع الذي وجدته عليه بحيث يكون هذا الوضع مريحا للمصاب قدر المستطاع.
٧-إذا تم استدعاء سيارة الإسعاف وكانت سيارة الإسعاف في طريقها إليك فلا تقم بتجبير الطرف المكسور وانتظر طاقم الإسعاف حيث أن لدى هذا الطاقم جبائر طبية ومتخصصه.
لماذا يجب علي التأكد من إبقاء المفاصل الواقعة فوق وتحت منطقة الكسر ساكنة دون حراك؟
إن نهاية كل عظمة من عظام الاطراف مرتبطة بمفصل، وحركة المفصل يترتب عليها حركة العظم المكسور لذا يجب ان تبقى المفاصل ساكنة لتظل العظام المكسورة أيضا ساكنة.
ماذا لو كان الكسر فى المفصل نفسه؟
هذا النوع من الكسور أصعب من الكسور في العظام الأخرى، ولكن يمكن تطبيق نفس الطريقة الخاصة بالتجبير. يجب التأكد من بقاء المفصل والعظام الواقعة فوق وتحت منطقة الكسر جميعها ثابتة. تخيل مفصل الكوع مثلا، انه يجمع عظم الذراع مع عظم الساعد وفي حالة الكسر يجب تثبيت المفاصل والعظام المرتبطة بها والحيلولة دون حركتها، لذا يجب إبقاء الرسغ والكتف في هذه الحالة ساكنين.
غالبا ما تحدث الإصابة للمفصل في وضع يكون المفصل فيه مؤلما جدا. في هذه الحالة لا تحاول تسوية وضع المفصل حيث أن هناك أعصاب هامة وأوعية دموية تتواجد حول المفصل وأية محاولة لتسوية أو تصحيح وضع المفصل قد ينجم عنه إتلاف للأعصاب والأوعية الدموية علاوة من أن تصحيح المفصل ينجم عنه ألم شديد.
عليك أن تكون ذا خيال واسع في تعاملك مع مثل هذه الإصابة، ويمكن تجبير المفصل في الوضع الذي يكون عليه.



ماهي المواد التي أحتاجها للتجبير؟

ستكون بحاجة إلى:

-جبيرة(صلبةأو مرنة)

-ضِمادَة سَمِيكَة تُوضَع تَحت الجبيرة لِتوفّر أكبر قدر ممكن من الراحة للمصاب. (اختياريه)

حبل أو شيء مشابه لربط الجبيرة بالطرف المكسور.

ماذا لو لم تتوفر المواد اللازمة للتجبير؟

لا داعي للقلق. يمكن استخدام جسم المصاب نفسه كجبيرة وذلك على النحو التالي:

.يمكن ربط الذراع المكسورة بواسطة عصابة إلى جسم المصاب .

.يمكن ربط الساق المكسورة بواسطة عصابة إلى الساق الأخرى للمصاب .

.يمكن ربط الإصبع المكسورة بواسطة عصابة إلى بقية أصابع المصاب .

اصابات العمود الفقري:

غالباً تنتج من حوادث السيارات او السقوط من علو واي خطا في التعامل مع ضحايا هذه الحوادث قد يعني ان يمضي الضحيه بقية عمره عاجزا ومقعدا لذا يجب مراعاة عدم تحريك اي مصاب يحتمل ان يكون لديه اصابه في العمود الفقري الابواسطة فريق متخصص ومدرب لمثل هذه الحالات فكن حذرا

كيف تعرف ان المصاب لديه اصابه في العمود الفقري

اطرح عليه هذه الاسئله: هل تحس بالام في ظهرك

هل يمكن تحس بقدَميك هل يمكن تحريك اصابع القدمين

اذا لم يستطع ذلك بالصوره الطبيعيه فتوقع حدوث اصابه فكن حذرا

خطوات إسعاف إصابات الظهر

إن إصابة الظهر أو العنق تعد إصابة بالغة الخطورة، وإذا تم نقل المصاب من موقع الحادث .بطريقة خاطئة فيمكن أن يصاب بالشلل الدائم. لا تنقل المصاب من مكان الحادث

تأكد من سلامتك الشخصية وسلامة المصاب ومن ثم تحقق من أساسيات الإسعاف الأولي .واستدع سيارة الإسعاف

إن لدى أطقم الإسعاف جبائر خاصة بالظهر والعنق كما أنهم على دراية بالطرق المثلى للتعامل .مع مختلف الإصابات

إسعاف الطفل بعد تعرضه لضربة على الرأس:

لا تقم بتحريك الطفل الذي يشتبه بإصابته بأذية في الرأس او العنق او العمود الفقري لان اي حركة للطفل هنا قد تؤذيه وتسبب أذية خطيرة ويجب عليك فقط طلب الطبيب او الاسعاف خاصة اذا كان لدى الطفل اي مما يلي

فقد وعي اوميل شديد للنوم -صداع مستمر او اقياءات - عدم القدرة على تحريك احد الأطراف سيلان الدم او سيلان سائل اصفر من الانف او من الاذن عند وجود الاختلاجات

عند وجود اضطراب في الوعي او السلوك او الكلام